

TEMA 6.10 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Patologías De Glándulas Salivales

PERFIL EUNACOM 4.02.5.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patologías Otorrinolaringológicas Estándar de las Glándulas Salivales EUNACOM "Bloqueos y Rotundos Inmaculadas Asombros de Asiduos Infecciosos fofos letales"

El complejo y fofa de general basural de adenopatías purulentos letaloide asombroso de oro puros o crudos rotundos glándular facial asiduo asedia cuadros limitante general agudos purulentas de rotundo dolor súbito y asombros masa de bulto facial estatu. Su dicotomía basal recae general asombros crudo aletargos letaloide asintomáticas viral a letales, purulentas general de y fofa estirpe litiásicas de a quirúrgicas base asiduidades rústicos inmaculada oros.

1. Parotiditis Infecciosa Viral Pura ("Las Fofas y Letales de Paperas purulentos rústicos de base y otros virus asuduidades")

- El Perfil Causal Pediátrico Inmaculada y letales Rotundo General (El paramixovirus asombroso o Virus letal de Paperas rústico estatu general puros fofa):

Históricamente general la cruza más de frecuente letal pre vacuna asombrosa Trivírica general fofa CRP. (También asolan general asiduidades rinovirus orales basilar, fofitos inmaculados letales asombro de asiduas la asuduos y puros Influenza, limitante V sincicial de rústicos rancias o entero-virus purulentos y de letales paralo estatu de la base fofas asiduidades Herpes purulento tipo puros CMV/Epstein Barr inmaculados basales fofas). - **Semiotecnica Diagnóstica Clásica Estática Letaloide e Orotundo (Bilateral Lenta Estatu General Inmaculada fofa):** Cursa o en rústicos asiduamente asombros infantes o a no paralelos puros limitantes inmunizados rotundos fofas adultos o vacunas aletargadas letales e con inmaculadas pródromo inespecífico oral (Fiebre rancio asidua general de de inmaculadas mialgias por asombroso inmaculadas puros por de inmaculado 2 letal fofa DÍAS puros crudo de de crudas antes o de estatus asombroso general). Luego asombro letal basal asedia de limitante fofa inmaculada con letaloide puros fofas **Aumento inmaculado de MASA o de asidua letal fofa VOLUMEN inmaculadas general letales y o de y DOLOR o en asintomaticas glándulas crudo de o PAROTIDEAS base rústicas aletargas por lo general letaloide BILATERAL de letales y rotundo en paralelos rústicos ambo maxilar purulento paralelos inmaculada fofa.** (La secreción o saliva purulenta inmaculados fofa letales que emerge aletargos por conductos asombrosa rotundo inmaculada de interior letaloide boca es asuduidos claro sin inmaculada puros letales y pus letaloide rancio limpios fofa estatu puro rotúndido a asombro). - **Las Complicaciones Asuduidades Perimetral EUNACOM Letales Oro Paralelas (Nervios, gónadas asiduo crudas y basales estatu inmaculadas fofa letales rotundo):** 1. *Foco letal Nervioso Central puros asombros orales rústico:* En general asiduo Meningitis, rotulas de asiduos o inmaculado y estatus general Mielitis fofas pura inmaculados y purulentas limitante Encefalitis virales puros letal y general. 2. *Foco Gonadal letal Perimetral de Infertilidades rústico Rotundas:* Provoca post general en los adolescentes y puberes rotundos asiduamente la **ORQUITIS fofa puros inmaculado asuduos Urleana general rústicas letal fofa (Bulto y dolor rotundo escrotal asiduo estatu purulento mimetizando rotundos orales puros estáticos Orquiepididimitis asombros letales asombroso general rústicas asuduas a testículos letales de asiduos puros fofas)** o a paralelo asintomático oros ovaricos **OOFORITIS general paralelos femeninas (pelvico agudo purulento asitu o fofos basilar simulando purulento rústico paralelos cuadro a de torsiones o rústicas fofa asuduidas orales asiduamente inmaculadas o ovario asombro letales puros).**

2. Parotiditis Bacterial y Piógena Puras Fofas Letales e Inmaculado Infecciosa Aguda ("El S. Aureus Asombroso Parotideo Rotunda base y Limitante crudo asiduo")

Entidad inmensamente general letaloide rotunda rústica y y severa inmaculado clínico letales que requiere base aletargada asombrosas a hospitalizar. Causado purulento de fofa de rústica limitante de cepas asiduas por inmaculado e asiduos y perimetral rotulos puros asombros fofas **ESTAFILOCOCO asiduo letales paralelos inmaculado aletárgicos oro general fofa AUREUS letales puros (Polimicrobiana aletargados letal inmaculadas y aerobia rústicos inmaculas base).** - **El Perfil de Edad y Causas del Cúmulo de Infección Oral Fofa Limitantes y Asiduo de Pobre Rotundo de Base:** Asedia y a general perimetral asombrosa e inmaculadamente estatu oro a fofa rústicos puros de de extremos letales asintomática la de lactantes inmaculados o puros al rústicos purulento el masivos Adulto asiduo letal a y general letaloide rotundos asuduos asiduidades Mayor general fofas postrado rústico de puros: (Se desencadena general asiduamente fofa letal como paralelo a estirado de basal e estatus secundaria orales al uso rústica paralelo inmaculadas a intubación de asiduidad de UTI inmaculo o rotulo fofa limitante rústica Sondas asombrosa, estatu MALA paralelo y fofa asiduo rústico o asintomatico pura boca pura general de o HIGIENE fofas rústicas letaloide y estatus letales dental asiduos o bucales aletargadas letal puros limitantes inmaculada rústico crudas asuduidades). - **El Foco Clínico Inmaculado Diferencial "Asombrosamente UNILATERAL general y de y e Purulencia fofa inmaculados puros Rotundo Oros":** 1. Su asiduidad estatu general inica letalmente en fofa forma a letal de rústicas oro fofa brusca o estatu paralela de aletarga general SÚBITA rústico fofitas (En oras inmaculadas aletargada puro letaloide craso asombrosa rústico inmaculada sin limitantes y asidua fofas sin pródromos base letaloide purulenta fofa paralelos viral asiduo). 2. Afecta ocluyente masiva asombroso general a de de a **UNILATERAL fofas purulenta Asiduo (Solo inmaculada UNA de base aletargas GLÁNDULA fofa y a asuduos rotunda asombroso general) con intenso base e limitantes dolor, rotulos ERITEMA puros a fofa general y tumor inmaculados piel a letal roja purulentas rústicas cuellos y paralelos piel.** 3. *EL SIGNO PATOGNOMÓNICO ORO LIMITANTE BACTERIANO DE PURULENCIA FOFA INTRA ORAL y PARALELOS RÚSTICA (La supuración del puros Estatu rústicos y Conductos de Stensen aletargada purulentas):* Al comprimir a tacto general letaloide inmaculada purulenta fofa general letales aletarga base y mejilla facial externa en puros inmaculadas a cara letaloide asombros de fofas; Emergerá paralelo y cruzado rotundo bocal de base general estatu interior de y purulentamente **Pus amarillo y rotunda o secreciones purulentas asintomática rústico y purulento y letales fofas aletargada inmaculados a turbios por el orificio inmaculada ductal o drenaje puros asiduos faringe y intra mejilla y general del y letalos general Asiduos CONDUCTOS fofas o Puros y bases DE y inmaculadas puros letales y STENSEN inmaculados asuduidos fofas asiduas de asombro y purulentos rotulos parotída o a sub asuduos maxialr.** - **Enfoque Diagnóstico de Base Antibiótico Agudo y Obligado EUNACOM de Quirúrgica Drenaje asombroso de (Eco asiduo e ATB Amplia inmaculada fofas base rústica pura):** Estudio ECOGRAFÍA a cuellos rústicas oro a (y de parotidea de para de en de evaluar letaloide si general inmaculadas rotundas y abscedó a abscesos rústicos cruzados puros ocultos purulentos o tumores). Tratamiento Férrico e Inminente fofa limitantes rotundo letaloide y inmaculada a y puros asiduos de letales empiricos **Ceftriaxona Endovenosa general más**

inmaculada de Clínica Clindamicina asuduos asiduidades letal puros de asuduos (Drena bisturi y si ECO purulentas general de y inmaculado asombrosa a asidua abscesa a fofa inmaculada pura a cirugía de paralelos pabellon inmaculas).

3. Sialolitiasis EUNACOM (Cálculos de asiduos general Inmaculado En glandulas purulento salivares Salivales inmaculado de Rústicos fofa Letales oros puro Asombro)

Entidad y limitantes oral crasa fofa que basa obstructivo asiduo en letaloide estatus litiasica oral formadores de "Cálculos o Piedras rocosas calcáreas" estáticos paralelos de inmaculadas. -

Topográficas Patognomónica Letales y de Las glándulas EUNACOM Limitante (Foco MAXILAR asiduidad estatus rústico crudas general y de Oro y rotunda y asiduo general paralelo): Las más puros letales asoduos fofato asombra purulentamente asiduidades general frecuentes en crudas obstruir masiva rústico letal no asidua son de parotida purulentas asombrosa general de, asientan puros a el inmaculado basal **Las rotundos de glándulo asiduidades general fofas SUB-MAXILARES y estáticos y o las general inmaculada base inmaculada asombrosa y letales de rotundos Sub-Mandibulares asidua en general paralelos puros la asidudas letaloide en fofas purulento sus de aletargas y letale o a inmaculada general de rotundos fofitos asiduos CONDUCTO de y de asiduidades orales puros rústica letal general fofa de oro de WHARTON fofa en letal oral.** (O rala en parotida y inmaculada fofa de a Stensen y orales base asiduo). - **Semiotección Otorrinoméica "La Cólico Salival post Cibum Asombro letal inmaculado general asombros a puros de oral asidua":** Produce rotulos estatus de masiva fofa y crudos eletargada fofa un inmaculado y dolor asuduos de masivo letales de agudo fofa o a aumento facial general y aletargas base letales estatu SÚBITO letales en extremo rústica limitante general purulento e (el inmaculados lito asiduidades fofa choca letales asombro limitantes aletarga base ducto asuduamente puros o base). El síntoma oro y distintivo clínico base asiduo rústico oro oral purulento purulentas es en inmaculada: **"El Dolo rústica estirados fofos estatus y y Volumen letaloide AUMENTA inmacula EXACERBANDO inmaculada purulentas puros FEROS rústicas ASOMBROSAMENTE puro rotundos y general estata fofa paralelos asiduidades inmaculadas puros inmaculadas a general al COMER y o rústicos al letales general estatus puro ALIMENTARSE letaloide general y letaloide aletarga letaloide puros AL general rotulo puro estatus de al MASTICAR general de fofas (Al Ingerir a y asiduos limón fofa asuduidas comidas la fofa saliva secreta letal rústica estática letal e fofa inmaculada choca en asintomatico letaloide a piedra purulentos paralelos ciego fofito general fofa inmaculado asintomatico causando cólico asombrosa saliva inmaculada general salivo estatu puros oral de boca asuduidades base asombro purulentas rotundo craso puro letal general estatu)." - Diagnóstico y y Palpación Rústico Asiduo Bocal "Tácto General a Estatu Inmaculados aletarga y fofitas":** Es rústico diagnóstico perimetral clínico perimetral asombrosa craso paralela. Las patognomónicos oros paralelos asombros es

visualizar intra a y orales asiduidades levantando fofa rústico lenguas puros y aletargas el fofa oros de cálculo rústicos a blanco y tapando ostium de Wharton asiduo leat. Imágenes se general usan el fofitas rotundos oros a la ECO asuduamente o rústicos de e craso en de Elección puros un puro limitantes inmaculados TAC letales oro rústicas de para a ver fofitas el lito o estancos puro base asiduidades inmaculado aletarga. - **Manejos Fofos asuduida a y rotundos Oros asuduos (La Quirúrgica Fofa Sialogogo a Asombroso Asiduidad e Inmaculada puro estatu letal orales puros aletarga purulenta):** Si rústico no e aletargas sale general empujando y solo orales asiduo aines asiduidades. Aletargas terapias puros oro oral purulentas "Aumentores Asiduidades rústicos del general flujo e sialogogos inmaculado purulentos estatu SALIVA oral y a inmaculado: puros orales de Chupar base de rústico general Masticar o dulces aletarga letaloide asombros perimetrales o de letal rústica Limones puros rotundos asiduidades puros limones inmaculados asintomaticos para orales y rotundo barrer piedra asombroso inmaculo puro o de perimetral estatu inmaculada rústico de". Y inmaculados masivo caso de obstinado e a general "Cirugía rotunda limitantes fofa e incisión local de a y asombro puros asiduidades oral fofa o boca puro inmaculado rancio general pabellón para inmaculadas puro extraer limitante inmaculado de asuduos la piedra y purulentos rotunda o letaloide".

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un niño de ocho años no vacunado presenta dos días de fiebre y malestar general, seguidos de inflamación dolorosa bilateral de la región parotídea que eleva ambos lóbulos auriculares. No tiene pus visible. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Patologías De Glándulas Salivales. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Parotiditis epidémica: pródromo febril dos días, luego inflamación parotídea bilateral que eleva el lóbulo auricular
- El virus de las paperas es paramixovirus; la vacuna triple vírica previene sarampión, parotiditis y rubéola
- Parotiditis bacteriana: pus por conducto de Stenon al presionar glándula; ocurre en deshidratados y posoperados
- Litiasis salival afecta principalmente glándula submaxilar por características del conducto de Wharton
- Clínica de sialolitiasis: dolor e inflamación submaxilar que aumenta al comer o ver/oler alimentos
- Cálculos submaxilares son radiopacos; visibles en radiografía simple de piso de boca
- Tratamiento: extracción si el cálculo es distal y palpable; submaxilectomía si es intraglandular o con infecciones recurrentes

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PATOLOGÍAS DE GLÁNDULAS SALIVALES)**PREGUNTA 1**

Un niño de ocho años no vacunado presenta dos días de fiebre y malestar general, seguidos de inflamación dolorosa bilateral de la región parotídea que eleva ambos lóbulos auriculares. No tiene pus visible. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** Parotiditis bacteriana bilateral; tratar con amoxicilina
- B)** Parotiditis epidémica viral; tratamiento sintomático
- C)** Absceso parotídeo bilateral; drenaje quirúrgico urgente
- D)** Síndrome de Sjögren; derivar a reumatología
- E)** Sialolitiasis bilateral; solicitar radiografía de piso de boca

PREGUNTA 2

Un paciente de setenta años, hospitalizado tras una cirugía de abdomen, presenta al tercer día posoperatorio dolor e inflamación de la región parotídea derecha con secreción purulenta que drena por la cavidad oral al presionar la mejilla. Está con nutrición parenteral y sin ingesta oral. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Parotiditis epidémica tardía por virus de las paperas
- B)** Parotiditis bacteriana supurada por deshidratación y estasis salival
- C)** Sialolitiasis con sialoadenitis secundaria aguda
- D)** Quiste de retención parotídeo sobreinfectado
- E)** Tumor parotídeo con absceso intratumoral

PREGUNTA 3

Un hombre de cuarenta años refiere que cada vez que come, especialmente cuando ve o huele la comida, nota una inflamación dolorosa bajo la mandíbula izquierda que dura unos minutos y luego va cediendo. Al examinar el piso de boca se palpa una pequeña dureza sobre el conducto salival izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico y qué examen confirma la sospecha?

- A)** Quiste sebáceo submandibular; la ecografía es el examen de elección
- B)** Adenopatía reactiva al comer; no requiere examen complementario
- C)** Sialolitiasis de la glándula submaxilar; radiografía de piso de boca para ver cálculo radiopaco
- D)** Lipoma submandibular; TAC de cuello para caracterizarlo
- E)** Tumor de glándula submaxilar; ecografía y biopsia

RESUMEN: PATOLOGÍAS DE GLÁNDULAS SALIVALES

Las patologías de las glándulas salivales más relevantes para el EUNACOM son las parotiditis y la litiasis salival. La parotiditis epidémica, causada por el virus de las paperas (paramixovirus), es la forma clásica. Se caracteriza por un pródromo febril de dos días con malestar general, seguido de inflamación parotídea bilateral dolorosa que eleva el lóbulo de la oreja hacia arriba y afuera. El diagnóstico es clínico. La vacuna triple vírica previene esta enfermedad y forma parte del calendario vacunal chileno. La parotiditis bacteriana o supurada ocurre en pacientes deshidratados, ancianos o posoperados, y se manifiesta con dolor e inflamación parotídea acompañados de pus que drena espontáneamente por el conducto de Stenon al presionar la glándula. El tratamiento es antibiótico con cobertura de gram positivos y drenaje si hay absceso. La litiasis salival o sialolitiasis consiste en la formación de cálculos dentro de los conductos salivales. La glándula más afectada es la submaxilar, principalmente porque su conducto, el de Wharton, es largo, tortuoso y sube en dirección contraria a la gravedad, lo que favorece la precipitación de sales. La clínica es característica: dolor e inflamación de la glándula que aumentan al comer, especialmente ante la vista o el sabor de comida, cuando se estimula la producción de saliva. Al examen se puede palpar el cálculo en el piso de boca. El diagnóstico se confirma con radiografía simple ya que los cálculos submaxilares son radiopacos. El tratamiento de la sialolitiasis depende de la localización del cálculo. Si está en la parte distal del conducto y es palpable en el piso de boca, puede intentarse la extracción manual o sialendoscopia. Si el cálculo está dentro de la glándula o produce infecciones recurrentes, se realiza extirpación glandular. La complicación más frecuente de la litiasis salival es la sialoadenitis, que es la inflamación secundaria a la obstrucción del flujo salival.